

Visita Domiciliaria: La Percepción Materna y la Nutrición Infantil en un Establecimiento de Salud de Lima Centro

Alicia Lucia Ludeña Leon

aliluciall@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2370-6156>

Universidad Nacional del Callao

Perú-Lima

Edwin Joel Ticlla Colunche

eticllac@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4739-1144>

Universidad Nacional Federico Villarreal

Perú-Lima

RESUMEN

El presente estudio exploró la relación entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional de niños de 6 a 36 meses atendidos en el servicio de nutrición del C.S. San Sebastián en Lima Cercado, durante el año 2023. Bajo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y correlacional, se encuestó a 40 madres utilizando un cuestionario validado de 15 ítems con una alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = 0.925), evaluando las dimensiones de planificación, ejecución y evaluación de las visitas. El estado nutricional infantil se determinó mediante indicadores antropométricos, bioquímicos y de ingesta dietética. Los resultados revelaron que la percepción materna predominante sobre la visita domiciliaria fue baja (27.5%), aunque también se observaron proporciones significativas en las categorías muy alta y muy baja (25% cada una). En cuanto al estado nutricional infantil, casi la mitad de los niños (52.5%) presentaron un estado adecuado. El análisis estadístico Chi-cuadrado demostró una relación significativa entre la percepción materna y el peso para la edad ($p=0.036$), los niveles de hemoglobina ($p=0.001$) y la ingesta dietética ($p=0.000$) de los niños. También se encontró una relación significativa entre la percepción materna general sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional global de los niños ($p=0.000$). En conclusión, el estudio evidenció una relación proporcional entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses en el contexto estudiado.

Palabras clave: visita domiciliaria, nutrición infantil, percepción materna, salud pública, anemia infantil

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.

Licencia: 

Home Visit: Maternal Perception and Child Nutrition in a Health Facility in Central Lima

ABSTRACT

The present study explored the relationship between maternal perception of home visits and the nutritional status of children aged 6 to 36 months attending the nutrition service at C.S. San Sebastián in Lima Cercado during 2023. Using a quantitative, descriptive, and correlational approach, 40 mothers were surveyed with a validated 15-item questionnaire exhibiting high reliability (Cronbach's Alpha = 0.925). The questionnaire evaluated the dimensions of planning, execution, and evaluation of the visits. Child nutritional status was determined using anthropometric, biochemical, and dietary intake indicators. The results revealed that the predominant maternal perception of home visits was low (27.5%), although significant proportions were also observed in the "very high" and "very low" categories (25% each). Regarding child nutritional status, almost half of the children (52.5%) presented an adequate status. Chi-square statistical analysis demonstrated a significant relationship between maternal perception and children's weight-for-age ($p=0.036$), hemoglobin levels ($p=0.001$), and dietary intake ($p=0.000$). A significant relationship was also found between overall maternal perception of home visits and the children's global nutritional status ($p=0.000$). In conclusion, the study evidenced a proportional relationship between maternal perception of home visits and the nutritional status of children aged 6 to 36 months in the studied context.

Keywords: *home visit, child nutrition, maternal perception, public health, child anemia*

The authors declare no conflict of interest.

The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.

License: 

INTRODUCCIÓN

Las visitas domiciliarias son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales estrategias a nivel de atención primaria. Estas visitas buscan acercar los servicios de salud a los hogares, permitiendo conocer de manera directa las necesidades del binomio madre-niño, considerado uno de los grupos más vulnerables. En contextos de escasos recursos económicos, donde la población infantil enfrenta problemas de malnutrición tanto por déficit como por exceso de peso, las visitas domiciliarias se presentan como una herramienta preventiva y de intervención que puede mejorar significativamente el estado nutricional de los niños.

En el Caribe y América Latina, el movimiento Fomento de la Nutrición (SUN, 2022) destaca la necesidad de intervenciones específicas para mejorar el estado nutricional infantil y combatir la malnutrición, enfocándose en acciones educativas que promuevan hábitos alimentarios saludables y fomentar interacciones positivas con los niños. En este contexto, la visita domiciliaria desempeña un papel crucial al influir directamente en la adopción de prácticas alimentarias adecuadas.

En el año 2023, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) reportó que la prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses fue de 37,5% a nivel nacional, mostrando una ligera reducción respecto al 38,8% registrado en 2021. En el caso de las mujeres de 15 a 49 años, la prevalencia de anemia fue de 20,6% en 2023, cifra superior al 18,0% observado en Lima Metropolitana en 2021, lo que indica una persistencia del problema en este grupo poblacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2024).

En cuanto a la desnutrición crónica infantil, la ENDES 2023 señala que el 11,0% de los niños menores de cinco años presentan esta condición a nivel nacional, una leve mejora frente al 11,5% reportado en 2021. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre

departamentos, siendo las regiones de la sierra y la selva las más afectadas, al igual que en años anteriores (INEI, 2024).

Respecto al sobrepeso y la obesidad, en 2023 el 62,3% de la población de 15 años a más presentó exceso de peso (sobrepeso u obesidad), cifra apenas inferior al 62,7% registrado en 2021. La prevalencia sigue siendo mayor en mujeres (65,4%) que en hombres (59,1%), manteniéndose la tendencia observada en años previos (INEI, 2024).

Se muestra una reducción marginal en la prevalencia de anemia y desnutrición crónica infantil respecto a 2021, mientras que el exceso de peso en adultos se mantiene prácticamente sin cambios. Estas cifras evidencian que, si bien se observan avances en algunos indicadores nutricionales, los desafíos en salud pública persisten en el país (INEI, 2024).

Mientras las evaluaciones tradicionales se enfocan principalmente en medir indicadores nutricionales específicos como peso, estatura, índice de masa corporal o análisis bioquímicos, el enfoque de la visita domiciliaria abarca además aspectos relacionados con la interacción directa con la familia en su entorno y su percepción. Esto permite entender no solo el estado nutricional sino también factores conductuales y sociales que influyen en la nutrición y la salud. A diferencia de las evaluaciones tradicionales que pueden ser puntuales y aisladas, la visita domiciliaria es un proceso continuo que incluye acompañamiento, monitoreo y apoyo adaptado a las necesidades y condiciones, favoreciendo mayor efectividad en los resultados nutricionales y de salud.

Esta situación resalta la importancia de las visitas domiciliarias, debido a que, al influir en los comportamientos familiares, pueden contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños. Para enfrentar esta problemática, el Plan Nacional bajo el programa presupuestal "Programa Articulado Nutricional" del Ministerio de Salud (MINSA) incluye visitas domiciliarias y consejerías dirigidas a menores de dos años, tanto con anemia como sin ella, promoviendo

una alimentación adecuada y el desarrollo de sus potencialidades.

No obstante, las visitas domiciliarias presentan limitaciones en su aplicación, especialmente en el primer nivel de atención, donde se centran en niños con anemia o en situaciones especiales. En Lima Metropolitana, según el Informe Técnico de Vigilancia de la situación del sobrepeso, obesidad y sus determinantes en el marco del Observatorio de Nutrición y estudio del sobrepeso y obesidad – 2023, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años fue de 8,7% y la de obesidad fue de 3,9% en 2022. Estas cifras muestran una ligera disminución respecto a años previos. En cuanto a la desnutrición crónica, la prevalencia fue de 6,2%, y la anemia afectó al 25,7% de los menores de cinco años en Lima Metropolitana (Luján-Del Castillo y Gómez-Guizado, 2023, pp. 20-21).

En el Centro de Salud San Sebastián de Lima Cercado, existe una alta demanda de atención nutricional para niños menores de tres años. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las visitas domiciliarias se suspendieron y solo se retomaron en 2022, afectando el seguimiento nutricional infantil. Las madres reportan que estas visitas suelen centrarse en la entrega de suplementos como el hierro, con escasa orientación alimentaria, lo que ha generado desinterés en algunos casos. Además, la organización para asignar al personal encargado de realizar las visitas ha sido deficiente, afectando la evaluación de los resultados y dificultando la identificación de cambios significativos en el estado nutricional de los niños. Es necesario un enfoque integral y multidisciplinario que involucre a diferentes profesionales de salud en coordinación con programas del gobierno local, a fin de fortalecer el estado nutricional infantil.

Este estudio aporta al estudio de la salud pública, ya que las visitas domiciliarias son intervenciones que permiten hacer el seguimiento a las intervenciones sobre la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población infantil, problemas que afectan tanto a áreas

urbanas como rurales. Además, permitirá revalorizar la visita domiciliaria como un indicador de cumplimiento institucional, así como una oportunidad de comunicación abierta entre el profesional de salud y las madres, promoviendo cambios en los hábitos alimentarios de sus hijos.

Comprender la forma cómo las madres perciben estas visitas y si las acciones realizadas cumplen con sus expectativas, permitirá optimizar el abordaje de los profesionales de salud involucrados, como nutricionistas, asistentes sociales, odontólogos y personal técnico, fomentando mejores prácticas de alimentación. De este modo, los resultados beneficiarán a las madres y niños menores de 6 a 36 meses del Centro de Salud San Sebastián y podrán replicarse en otros establecimientos de salud de la jurisdicción.

Los resultados de esta investigación pueden contribuir a fortalecer y aumentar la cantidad de visitas domiciliarias, con el objetivo de mejorar el seguimiento a las madres. Esto permitirá un monitoreo más efectivo del cumplimiento de las atenciones programadas, incentivando la asistencia puntual a sus controles. Además, se facilitará que las madres brinden correctamente el suplemento de hierro a sus hijos, gracias a una orientación profesional adecuada que desmantele los mitos y dudas que actualmente predominan. Asimismo, los hallazgos pueden influir en las autoridades de salud para revalorizar la importancia de las visitas domiciliarias dentro de las diversas estrategias, como el Programa Articulado Nutricional del MINSA.

El estudio se fundamenta en la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, teoría del apego de Bowlby y la teoría cognitiva de Neisser. En este contexto, la percepción materna de las visitas domiciliarias es influenciada a partir de experiencias que se presentan desde relaciones más cercanas de microsistema (familia, amigos) hasta de factores presentes en el macrosistema como creencias y valores compartidos de su entorno y que a su vez estas percepciones influyen directamente en las prácticas de alimentación infantil. Bowlby (1980,

p.318) aborda la percepción como un proceso activo y selectivo, mediado por los esquemas cognitivos, filtrada por experiencias pasadas, que organiza la interpretación de estímulos internos y externos para garantizar la seguridad y supervivencia.

A partir de los aportes de Bronfenbrenner (1979), la percepción está mediada por los sistemas ecológicos (micro, meso, sexo y macrosistema), filtrada por las interacciones inmediatas y lo considera como un proceso activo en el que el individuo no solo recibe estímulos, sino que los interpreta en función de sus interacciones sociales, estructuras culturales más amplias y contextos ambientales.

Ulric Neisser (1967), presenta la percepción como un proceso de construcción mental. El ser humano explora su entorno, selecciona información relevante y la organiza mediante patrones cognitivos llamados esquemas. Estos esquemas, desarrollados a través de experiencias previas, sirven como guías para interpretar los estímulos sensoriales (p.22). Neisser concibe la percepción como un acto creativo de interpretación. Cada individuo genera su comprensión del mundo basándose en sus experiencias acumuladas y sus objetivos inmediatos.

En el caso de las visitas domiciliarias, la percepción de las madres sobre esta intervención depende de factores internos (actitudes, personalidad, estado emocional) y externos (novedad e intensidad del estímulo). Por lo tanto, mejorar la planificación, ejecución y evaluación de estas visitas es valioso para lograr su efectividad.

Para la interpretación de los resultados de la encuesta aplicada, se clasifican los puntajes en cuatro niveles que tienen la siguiente descripción:

- Un puntaje muy alto indica que la madre percibe las visitas domiciliarias como altamente efectivas y satisfactorias, considerando que el programa cumple completamente con sus expectativas. Esto refleja una alta confianza en el profesional

de salud y en la utilidad de las intervenciones, siendo un indicador de que el programa de visitas es muy exitoso desde la perspectiva del usuario.

- Un puntaje alto representa una buena percepción general con algunas áreas menores de mejora. La madre valora positivamente la mayoría de los aspectos del programa, lo que indica que es efectivo y funciona bien, aunque podría optimizarse en ciertos aspectos específicos para alcanzar la excelencia.
- Un puntaje bajo sugiere que la madre identifica deficiencias significativas en el programa, con problemas evidentes en la planificación, ejecución o seguimiento de las visitas. Esto indica la necesidad de revisar y mejorar aspectos específicos del programa para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de las beneficiarias.
- Un puntaje muy bajo refleja una percepción muy negativa del programa de visitas domiciliarias, donde la madre considera que las visitas no cumplen con sus necesidades. Esto sugiere posibles problemas graves en la implementación del programa y requiere una reestructuración completa del mismo o un cambio de enfoque para lograr los objetivos deseados.

El estado nutricional de los niños se evalúa mediante indicadores antropométricos (peso, talla y edad) y parámetros bioquímicos como la concentración de hemoglobina. En el Perú, la anemia en menores de tres años está asociada principalmente a una dieta deficiente en alimentos de alto valor biológico, así como a prácticas inadecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria. La Norma Técnica de Salud actualizada señala que “la principal causa de anemia por deficiencia de hierro en la niña y el niño es la ingesta insuficiente de hierro de alta biodisponibilidad, debido a una alimentación inadecuada y a la baja frecuencia de consumo de alimentos de origen animal” (Ministerio de Salud del Perú, 2024, p. 18). Además, la medición del peso y la talla permite detectar problemas nutricionales, mientras

que la determinación del nivel de hemoglobina es fundamental para el diagnóstico de anemia (Ministerio de Salud del Perú, 2024, p. 25).

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la percepción materna sobre las visitas domiciliarias y el estado nutricional de niños de 6 a 36 meses. A través del análisis de la información recopilada, se busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción materna respecto a las visitas domiciliarias y cómo se relaciona con el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses atendidos en el Servicio de Nutrición del Centro de Salud San Sebastián en 2023?

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología del estudio adoptó un enfoque fundamental, orientado a generar y ampliar conocimiento científico. Dado el objetivo general, se diseñó una investigación no experimental, de nivel descriptivo-correlacional y corte transversal, con el propósito de identificar patrones de comportamiento en las madres y analizar la relación entre su percepción de las visitas domiciliarias y el estado nutricional de sus hijos de 6 a 36 meses. La recolección de datos se llevó a cabo en un único momento, sin manipulación deliberada de las variables independientes. Se empleó el método deductivo para derivar conclusiones, las cuales fueron posteriormente analizadas.

La población objetivo estuvo constituida por 40 madres y sus niños de 6 a 36 meses que contaban con al menos dos visitas domiciliarias y una evaluación nutricional previa entre enero y mayo de 2023. Se utilizó muestreo por conveniencia, debido al tamaño de la población, se incluyó a todas las madres que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: madres de niños de 6 a 36 meses que desearon participar, niños de 6 a 36 meses afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), niños de 6 a 36 meses con atención nutricional registrada en el padrón del Servicio de Nutrición de 2023, niños de 6 a 36 meses homologados

en el padrón nominal del establecimiento de San Sebastián y niños de 6 a 36 meses con al menos tres visitas domiciliarias previas a su primera atención nutricional en 2023.

Se excluyeron niños menores de 6 meses o mayores de 36 meses, aquellos sin SIS o con SIS inactivo, niños pendientes de atención o homologación nutricional, niños con tratamiento médico por alguna patología, y niños sin visitas domiciliarias previas a su primera atención nutricional en 2023.

La adopción del muestreo por conveniencia se justifica principalmente por las dificultades que presenta el acceso a la población objetivo, dado que las madres deben cumplir criterios específicos para participar, además de expresar su voluntad de hacerlo. La alta tasa de inasistencia a los controles programados dificulta aún más la localización y reclutamiento de participantes, por lo cual se optó por incluir a todas las madres y niños que cumplieran con los criterios establecidos, conformando una muestra de 40 madre-niño de entre 6 y 36 meses.

El muestreo probabilístico no fue factible debido a la limitada accesibilidad y a la especificidad del perfil requerido, lo que restringe la posibilidad de seleccionar aleatoriamente una muestra representativa. En cambio, el muestreo por conveniencia permitió obtener información valiosa directamente de la población accesible que cumple con las características necesarias para el estudio.

El estudio se llevó a cabo en los hogares de los niños de 6 a 36 meses pertenecientes a la jurisdicción del Establecimiento de Salud San Sebastián, ubicado en Lima Cercado cuya unidad ejecutora es la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. Las mediciones antropométricas y bioquímicas se realizaron en el Servicio de Nutrición del mismo establecimiento.

Para la recolección de información de percepción de la visita familiar se elaboró un cuestionario con escala de Likert de 15 ítems, y validado mediante juicio de expertos (validez

de 0.031) y con una confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.925 para la variable percepción materna (Planificación $\alpha = 0.869$, Ejecución $\alpha = 0.790$, Evaluación $\alpha = 0.819$). El cuestionario exploró tres dimensiones: Planificación (ítems 1-6), Ejecución (ítems 7-11) y Evaluación (ítems 12-15), con un puntaje de 1 a 5 por ítem (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo). Para la clasificación de la percepción materna en categorías de muy bajo, bajo, alto y muy alto se empleó el método estadístico de bisagras de Tukey, a partir del cálculo de cuartiles, pues según Bennett & Vickers (2012), estos facilitan la clasificación de la muestra en niveles como bajo, medio y alto, basándose en criterios estadísticos y evitando límites establecidos de manera subjetiva o sin justificación clínica. Obteniéndose como primer cuartil ($Q1=50.50$), segundo cuartil ($Q2=56.00$) y tercer cuartil ($Q3=63.50$). A partir de ello, se procede a clasificar los niveles de los puntajes en muy bajo (<50.5), inferior al $Q1$, bajo entre el $Q1$ y $Q2$ ($[50.5-56>)$), alto entre el $Q2$ y $Q3$ ($[56-63.5>)$) y muy alto (≥ 63.5) superior al $Q3$. El uso de este método de bisagras de Tukey se utiliza siguiendo la línea de otras investigaciones precedentes y porque permite una clasificación estadísticamente respaldada que define los niveles de percepción a partir de la distribución de los datos, reduciendo la arbitrariedad en la delimitación de categorías. Este método se basa en los cuartiles, que dividen la muestra en partes iguales, facilitando así identificar diferencias significativas entre grupos sin depender de umbrales predefinidos.

La aplicación del cuestionario requirió el consentimiento informado de las madres, previa verificación de que sus hijos hubieran recibido al menos dos visitas domiciliarias antes de su primera atención nutricional en 2023.

Adicionalmente, para minimizar el sesgo social se implementaron estrategias orientadas a promover respuestas honestas y espontáneas. Para ello, la recolección de datos se llevó a cabo en los hogares de cada madre, por lo que promovió la confianza y disminuyó la presión

social asociada a responder lo que se considera "con el mayor puntaje". Antes de iniciar la encuesta, se brindó una explicación clara sobre los fines del estudio y se enfatizó que las respuestas no tendrían consecuencias sobre la atención nutricional de sus menores. Además, el cuestionario fue aplicado por personal capacitado en un trato humanizado, evitando cualquier juicio o gesto que pudiera inducir respuestas deseadas.

Las preguntas fueron formuladas con lenguaje claro y no valorativo; por ejemplo, en lugar de decir "¿el número de visitas realizadas cumplieron con las necesidades de su niño se utilizó" "¿Considera que el número de visitas que recibe es de acuerdo a las necesidades de su niño?", favoreciendo así respuestas basadas en la percepción real, expresando distintos grados de acuerdo, a fin de reducir el riesgo de sobreestimación por deseabilidad social.

Por otro lado, se registró información antropométrica (peso y talla) y bioquímica (hemoglobina) utilizando los protocolos y equipos del establecimiento de salud, así como datos de la ingesta dietética a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el cual fue registrado en las historias clínicas. En este instrumento se consignaba si se cumplía o no con la frecuencia recomendada para cada ítem, agrupado en seis categorías alimentarias: lácteos (diario), carnes como hígado, pollo y pescado (diario), menestras y legumbres (tres veces por semana), frutas y verduras (diario), y frituras y bocaditos (nunca). Los datos obtenidos fueron ingresados y analizados mediante el programa estadístico SPSS 26, presentando los resultados en tablas y gráficos.

La contrastación de hipótesis se realizó mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado. Se garantizó el cumplimiento de los aspectos éticos en la investigación, solicitando el consentimiento informado de las madres y asegurando la confidencialidad de la información, así como el reconocimiento de la autoría de los datos mediante citas y referencias según la normativa de APA.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la información recogida y sistematizada, en la Tabla 1 se describe que la percepción materna sobre la visita domiciliaria en el C.S San Sebastián presenta el predominio de la categoría de bajo [50.5-56> con 27.5%, seguido de 'muy bajo' y 'muy alto' con un 25% en ambas y finalmente de alto con un 22.5%. Por otro lado, al agruparlas encontramos que las categorías de muy bajo y bajo (52.5%) son ligeramente mayores a las de alto y muy alto (47.5%). Es importante precisar que, cuando se indica el nivel 'muy alto' hace referencia a que la madre considera las visitas domiciliarias altamente efectivas, con plena satisfacción y confianza en el programa y el profesional de salud.

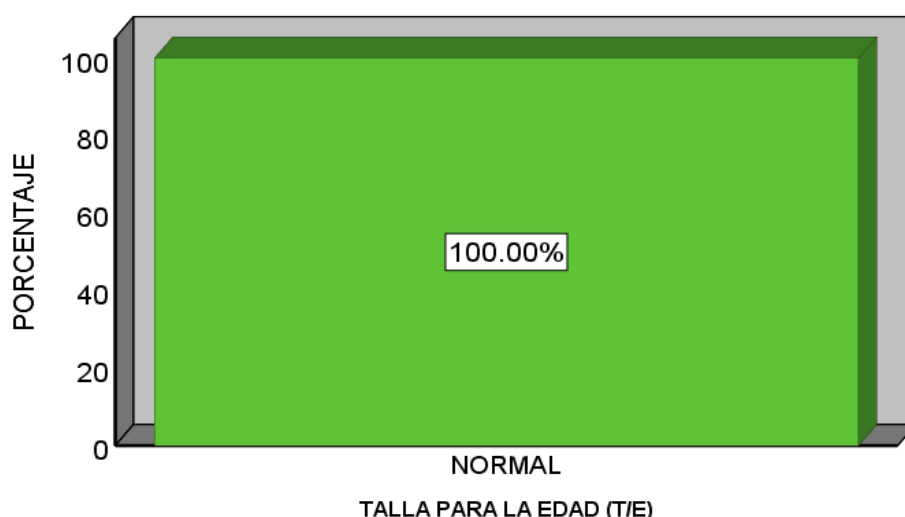
Tabla 1 Nivel de la percepción materna sobre la visita domiciliaria del C.S San Sebastián, 2023

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo <50.5	10	25.0
Bajo [50.5-56>	11	27.5
Alto [56-63.5>	9	22.5
Muy alto >= 63.5	10	25.0
Total	40	100.0

Nota: elaboración propia

En la Figura 1, los resultados muestran que, la categoría normal predomina en su totalidad representando al 100% según la talla para la edad en los niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián.

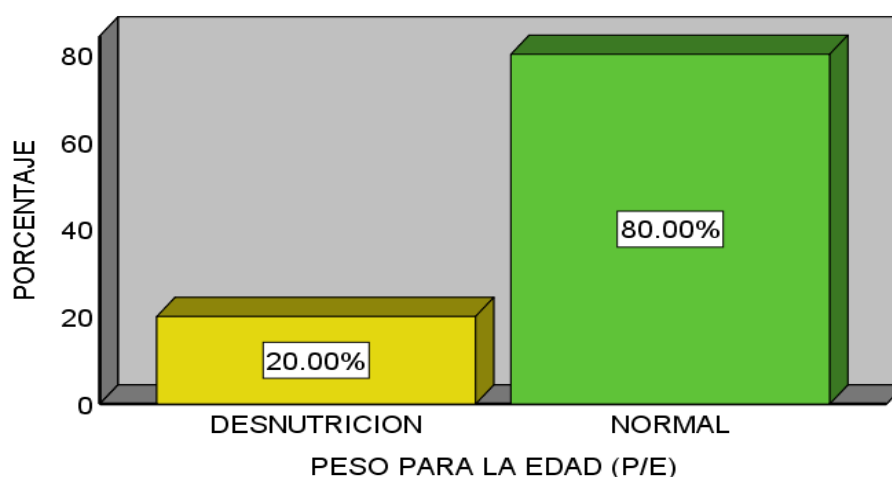
Figura 1 Talla para la edad en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023



Nota: elaboración propia

En la Figura 2, los resultados demuestran que el peso para edad en niños de 36 meses del C.S San Sebastián de 6 a 36 meses, la proporción que predomina es de desnutrición (80%) comparada a la de normal (20%) estableciendo una relación de 4:1.

Figura 2 Distribución porcentual según categoría del peso para la edad en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023



Nota: elaboración propia

En la Figura 3, los resultados muestran que, de acuerdo a la talla para edad en los niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, la categoría normal predomina en su totalidad con un

100%.dev

Figura 3 Peso para la edad en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023



Nota: elaboración propia

En la Tabla 2, los resultados demuestran que, la categoría normal (52.5%) es ligeramente mayor a la de anemia leve (42.5%), sin embargo, la anemia en sus dos niveles presenta un 47.5 % acercándose a casi la otra mitad de los niños evaluados de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián.

Tabla 2 Diagnóstico de anemia en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023

<i>Diagnostico</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Anemia moderada	2	5.0
Anemia leve	17	42.5
Normal	21	52.5
Total	40	100.0

Fuente: Centro de Salud San Sebastián-Lima, 2023

En la Tabla 3, los resultados muestran que la categoría adecuada es ligeramente mayor (57.5%) a la inadecuada (42.5%) en referencia a la ingesta dietética en los niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián.

Tabla 3 Ingesta dietética en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023

Diagnostico	Frecuencia	Porcentaje
Inadecuado*	17	42.5
Adecuado*	23	57.5
Total	40	100.0

Nota: elaboración propia

En la Tabla 4, los resultados muestran que los niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián presentan la categoría adecuada (52.5%) ligeramente mayor a la inadecuada (47.5%) de acuerdo con su estado nutricional.

Tabla 4 Estado nutricional en niños de 6 a 36 meses del C.S San Sebastián, 2023

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Inadecuado*	19	47.5
Adecuado*	21	52.5
Total	40	100.0

Nota: elaboración propia

En la Tabla 5, el nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria no guarda una relación proporcional con la talla para la edad. Es decir, ante un cambio en los puntajes de la talla para la edad es independiente a la categoría de percepción materna.

Tabla 5 Relación de la percepción materna sobre la visita domiciliaria y la talla para edad en niños de 6 a 36 meses

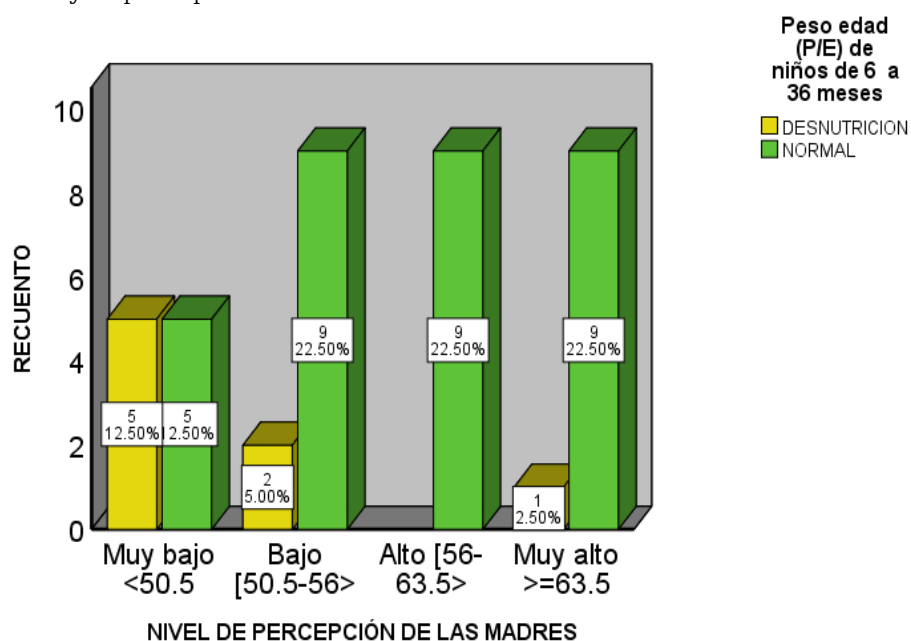
niños de 0 a 55 meses

Tabla cruzada de nivel de percepción y T/E						T/E	
						Normal	Total
Nivel de percepción	Muy bajo	Recuento				100	10
		% dentro del nivel de percepción	100%	100%			
	Bajo	Recuento				11	11
		% dentro del nivel de percepción	100%	100%			
	Alto	Recuento				9	9
		% dentro del nivel de percepción	100%	100%			
	Muy alto	Recuento				10	10
		% dentro del nivel de percepción	100%	100%			
Total						40	100.0
						100%	100%

Nota: elaboración propia

En la Figura 4, el nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria (bajo) sobre la visita domiciliaria es directamente proporcional con la desnutrición e inversamente proporcional al diagnóstico de normalidad. Es decir, ante un puntaje menor en la percepción materna, los niños tienen un deficiente estado nutricional de desnutrición, según el peso para la edad (P/E).

Figura 4 Distribución porcentual de la relación de la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el peso para la edad en niños de 6 a 36 meses



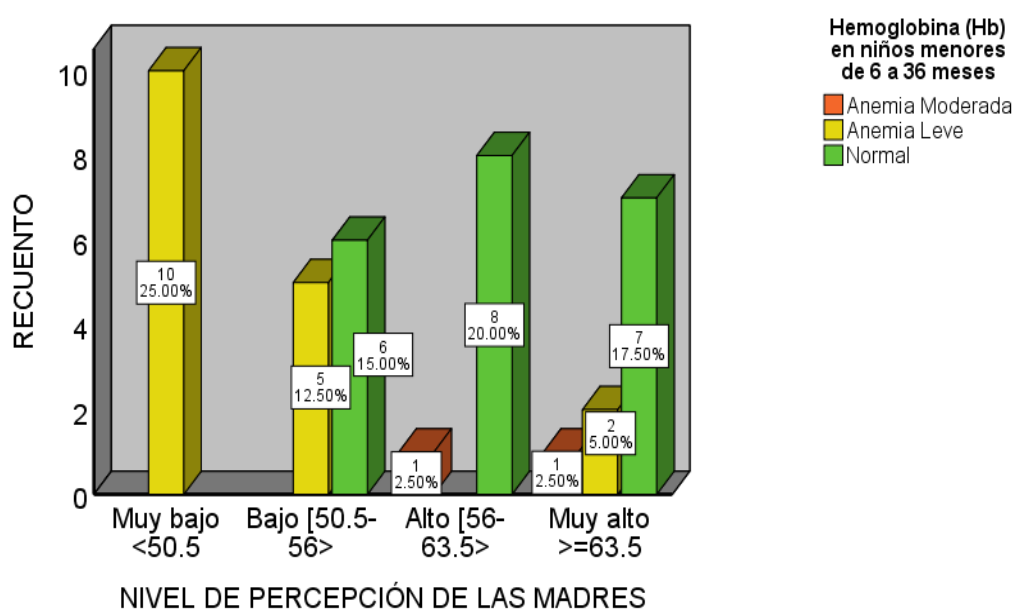
Nota: elaboración propia

Así mismo, el nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria (alto) y (muy alto) es directamente proporcional con el estado de normalidad según el peso para la edad. Por lo que, a un mayor puntaje en la percepción materna, mejor es el estado nutricional del P/E en los niños. El nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria no guarda una relación proporcional con el peso para la talla. Es decir, ante un cambio en los puntajes de desviación estándar de la talla para la edad es independiente a la categoría de percepción materna.

En la Figura 5, el nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria (alto y muy alto) son directamente proporcionales con el diagnóstico de normalidad para la hemoglobina (hb) en los niños e inversamente proporcional a los grados de anemia (leve y moderada). Es decir,

ante un puntaje mayor en la percepción materna, los niños tienen un mejor nivel de hemoglobina, y a medida que estos niveles descienden de su rango normal, en grados de leve y moderada, los puntajes de percepción materna disminuyen ubicándose en los niveles bajo y muy bajo.

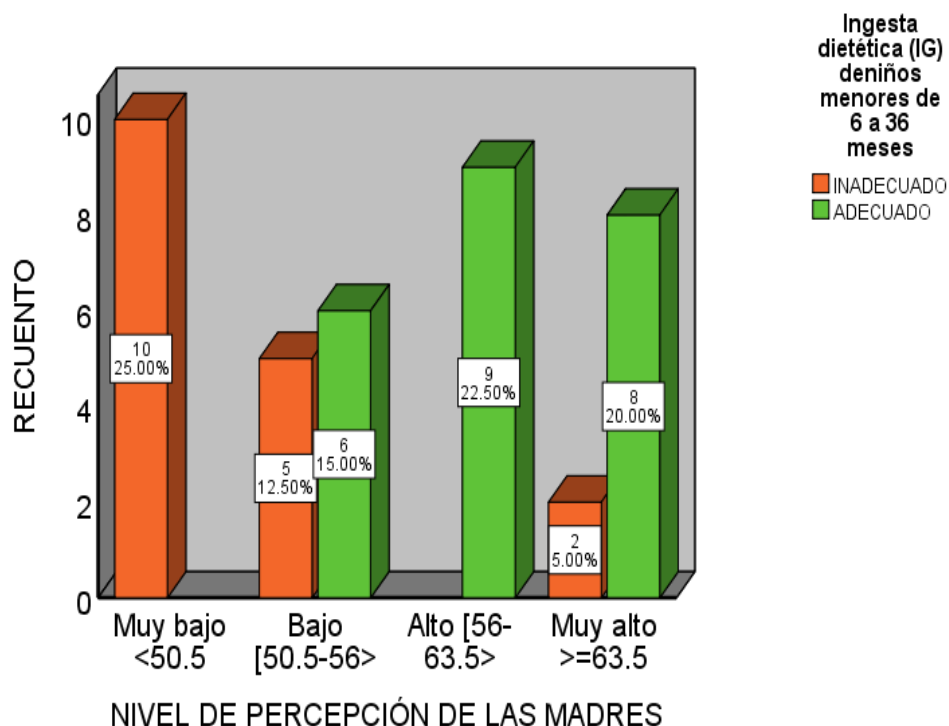
Figura 5 Distribución porcentual de la relación de percepción materna sobre la visita domiciliaria y la hemoglobina de niños de 6 a 36 meses



Nota: elaboración propia

En la Figura 6, el nivel de percepción materna sobre la visita domiciliaria (alto y muy alto) son directamente proporcionales con la adecuada ingesta de alimentos de los niños, es decir en el cumplimiento de la frecuencia estándar en lácteos, proteínas de alto valor biológico, menestras, cereales, tubérculos, así como frutas, verduras y frituras. Sin embargo, cuando la percepción materna desciende, es decir este consumo no se da de acuerdo con el rango de frecuencia esperado, e inversamente proporcional a los grados de anemia (leve y moderada). Por lo que el nivel de percepción materna es proporcional a una adecuada ingesta e inversamente proporcional a inadecuada ingesta.

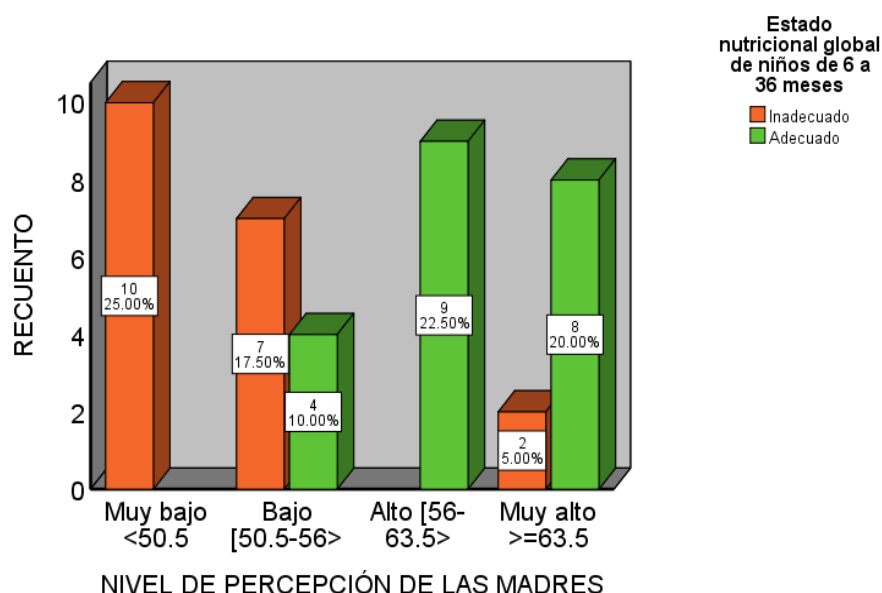
Figura 6 Distribución porcentual de la relación de la percepción materna sobre la visita domiciliar y la ingesta dietética de niños de 6 a 36 meses



Nota: elaboración propia

En la Figura 7 los resultados muestran que, a medida que los niveles de percepción materna sobre la visita domiciliar van aumentando de puntaje, el estado nutricional obtenido a partir de los indicadores antropométricos (p/t, t/e y p/e), bioquímico (hb) y dietética (frecuencia de consumo) de los niños también es favorable siendo adecuado. Y a medida que la percepción materna descende, existe la presencia de un diagnóstico deficiente en cualquiera de los indicadores nutricionales anteriormente mencionados. Por lo que, la percepción materna es directamente proporcional con el estado nutricional adecuado de los niños e inversamente proporcional con el estado inadecuado.

Figura 7 Distribución porcentual de la relación de la percepción materna sobre la visita domiciliaria y estado nutricional en niños de 6 a 36 meses



Nota: elaboración propia

En la Tabla 6, la distribución de los puntajes en las dimensiones de planificación, evaluación y ejecución de la visita domiciliaria, agrupados de menor a mayor, obteniéndose como primer cuartil (Q1=50.50), segundo cuartil (Q2=56.00) y tercer cuartil (Q3=63.50). A partir de ello, se procede a clasificar los niveles de los puntajes en muy bajo (<50.5) inferior al Q1, bajo entre el Q1 y Q2 ([50.5-56>), alto entre el Q2 y Q3 ([56-63.5>) y muy alto (>= 63.5) superior al Q3.

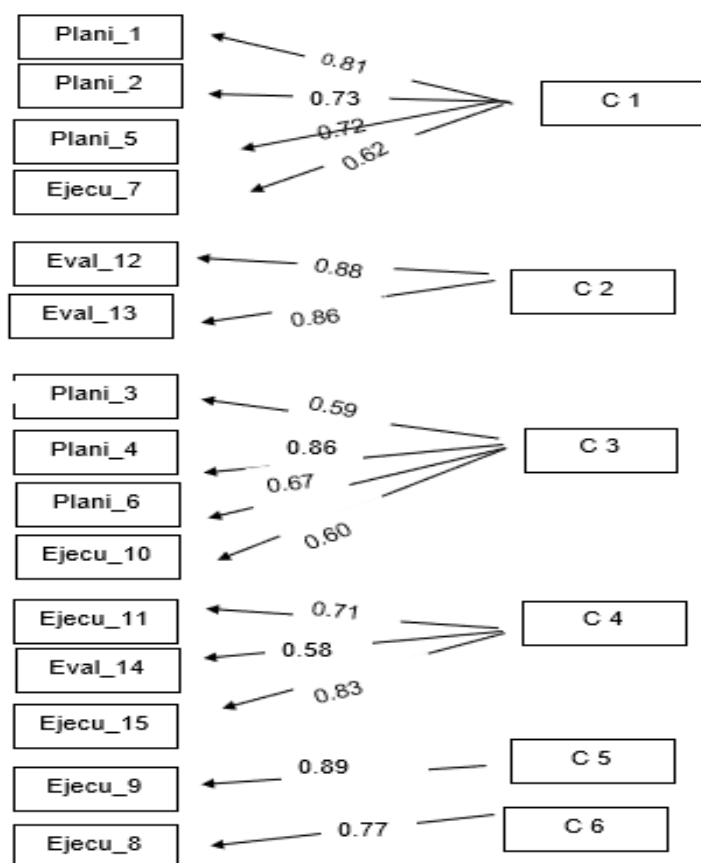
Tabla 6 Percentiles de la percepción materna sobre la visita domiciliaria del C.S San Sebastián, 2023

Percentiles		5	10	25	50	75	90	95
Promedio	Planificación	12.05	13.00	18.50	23.00	26.00	28.00	29.90
	Evaluación	12.05	13.10	16.50	20.00	21.00	23.00	23.00
	Ejecución	8.00	8.20	12.00	16.00	17.00	17.00	18.95
	Total	30.30	38.1	50.25	56.00	63.75	67.00	68.00
Bisagras de Tukey	Planificación			19.00	23.00	26.00		
	Evaluación			17.00	20.00	21.00		
	Ejecución			12.00	16.00	17.00		
Total				50.50	56.00	63.50		

<50.5: muy bajo, [50.5-56>: bajo, [56-63.5>: alto, >= 63.5: muy alto

En la Figura 8, luego de aplicar la prueba estadística de Kaiser Meyer lkin (KMO), el cual resultó de 0.73. Se procedió a realizar el análisis factorial, permitiendo la exploración intrínseca de las variables, es decir de la relación entre sí de los 15 ítem correspondientes a las dimensiones de planificación, evaluación y ejecución de la visita domiciliaria.

Figura 8 Análisis factorial de las dimensiones de la percepción materna sobre la visita domiciliaria del C.S San Sebastián, 2023



Los valores más cercanos a 1, por lo que el contenido de sus ítems guarda una estrecha vinculación. Es decir, los factores subyacentes de C1 agrupa a los ítems de planificación y ejecución relacionados al tiempo antes y durante de la visita, C2 que agrupa a los ítems de evaluación, en donde se vincula a las mejoras y su aplicación, C3 agrupa a los ítems de planificación y ejecución que engloba a las pautas y propósitos y C4 a los de ejecución y evaluación, que establecen coherencia en las recomendaciones brindadas por el profesional

Por otro lado, los ítems relacionados con confianza (C5) y los mensajes durante la visita (C6), según la prueba estadística, no parecen estar relacionados con otros ítems del cuestionario de percepción sobre la visita domiciliaria. Sin embargo, al agrupar 13 ítems, lo que representa la mayoría, se fortalece la confirmación de la validez del cuestionario. .

DISCUSIONES

Se han contrastado diversos estudios tanto a nivel nacional como internacional que investigan las variables relacionadas con la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional de niños de 6 a 36 meses, los cuales presentan una conexión directa con el planteamiento propuesto.

En cuanto a la percepción materna sobre la visita domiciliaria, se observó que predomina una percepción baja en el 27.5% de los casos, mientras que solo el 22.5% de las madres manifestó una percepción alta. Mejía-Merino et al. (2021) obtuvieron resultados similares al encontrar que la mayoría de las madres aceptan la visita domiciliaria, con un nivel de satisfacción del 30%, considerado bueno. No obstante, identificaron aspectos que los profesionales aún no logran integrar durante la visita, como la paciencia y la amabilidad, elementos fundamentales para generar cambios significativos en las prácticas alimentarias de los niños.

De igual manera, investigaciones realizadas por Marques et al. (14) y Guevara Heliana (17) reportaron una percepción materna regular luego de la ejecución de visitas domiciliarias, con un 36% y 37.7% respectivamente, lo cual coincide con los hallazgos del presente estudio.

El estado nutricional fue evaluado mediante indicadores antropométricos, bioquímicos y de ingesta dietética, mostrando que el 52.5% de los niños presenta un estado adecuado, mientras que el 47.5% muestra alguna deficiencia en uno de los indicadores. Predomina la desnutrición leve en el 20% de los casos, y casi la mitad de los niños evaluados (47.5%) presenta niveles bajos de hemoglobina, acompañados de una ingesta insuficiente de alimentos proteicos de

alto valor biológico ricos en hierro en el 42.5%.

Los resultados de este estudio indican una relación significativa entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional de los niños de 6 a 36 meses (p valor = 0.000). Según Hughes Kere et al. (2019), dedicar un mayor tiempo durante la visita a la atención del niño (96%) mejora la percepción materna, destacando la concordancia entre madre y profesional, el contenido de la interacción y la participación activa en el abordaje nutricional (17).

Asimismo, Choquehuanca (2021) concluyó que la percepción positiva de la madre sobre los servicios extramurales, como la visita domiciliaria, contribuye al mejoramiento de los indicadores nutricionales de los niños (19).

Respecto a la relación entre la percepción materna y los distintos indicadores nutricionales, se encontró que el índice de peso para la edad es el único indicador antropométrico que muestra una correlación significativa (p valor = 0.036). Esto sugiere que dicho índice puede reflejar cambios tempranos provocados por variaciones en la ingesta nutricional o desequilibrios asociados a enfermedades agudas, como la anemia (34). Mejía et al. (2021) demostraron que el compromiso y la adopción de recomendaciones nutricionales promovidas por el Programa de Visitas Domiciliarias favorecen el estado antropométrico de los niños mediante el incremento del peso y la talla (15).

En cuanto al indicador bioquímico, el presente estudio encontró que la percepción materna sobre la visita domiciliaria está significativamente relacionada con el nivel de hemoglobina (p valor = 0.001). De Avalos L (2020) también identificó que, tras realizar tres visitas domiciliarias en un periodo de seis meses, con mensajes motivadores y de calidad, se logra un aumento significativo de la hemoglobina y una reducción de la anemia en un 86% de los niños de 6 a 36 meses (20). Por su parte, Guevara H (2020) advierte que una deficiente orientación por

parte del personal de salud durante la visita puede generar una percepción negativa en las madres, lo que a su vez retrasa la recuperación del nivel de hemoglobina en los niños, afectando al 45% de los evaluados (21).

Respecto al indicador dietético, se determinó que la percepción materna influye en la ingesta alimentaria de los niños (p valor = 0.000), dado que la interpretación de las madres sobre la visita repercute en la inclusión de alimentos energéticos, proteicos y reguladores en la dieta infantil. Fuentes Sandoval et al (2018) también señalaron que una orientación inadecuada por parte del profesional de salud durante la visita puede dificultar la comprensión del mensaje, afectando la adherencia a la suplementación preventiva en niños de 12 a 24 meses (22).

CONCLUSIONES

Los hallazgos del presente estudio revelan una relación proporcional y estadísticamente significativa ($p < 0.001$) entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el estado nutricional de sus hijos. Específicamente, se concluye que una percepción materna baja se asocia a una interpretación negativa de las visitas domiciliarias por parte del profesional de salud, lo que a su vez impacta negativamente en el estado nutricional de los niños.

Asimismo, se identificó una relación significativa ($p = 0.036$) entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el índice de peso para la edad de los niños, indicando que una percepción baja por parte de la madre incrementa la probabilidad de desnutrición leve en sus hijos.

En cuanto al indicador bioquímico, se encontró una relación significativa ($p = 0.001$) entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y el nivel de hemoglobina (Hb) en los niños, sugiriendo que una percepción materna desfavorable se relaciona con un mayor riesgo de malnutrición por déficit.

Finalmente, se determinó una relación altamente significativa ($p < 0.001$) entre la percepción materna sobre la visita domiciliaria y la ingesta dietética de los niños. Esto sugiere que una percepción materna baja coincide con una ingesta inadecuada de diversos grupos de alimentos en la dieta de los niños. En conjunto, estos resultados resaltan la importancia de la percepción materna sobre las intervenciones de visita domiciliaria como un factor influyente en el estado nutricional infantil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avalos Aparicio, L. (2019). Factores asociados a la adherencia al tratamiento de hierro, en niños menores de 3 años, del Centro de Salud Virgen del Pilar, Diris Lima Centro, periodo 2018-2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada San Juan Bautista]. Repositorio Institucional UPSJB.

<https://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/2549>

Bennette & Vickers. (2012). Against quantiles: categorization of continuous variables in epidemiologic research, and its discontents, Journal: BMC Medical Research Methodology: 2012, ISSN: 1471-2288. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-21>

Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression. New York: Basic Books.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

Choquehuanca García, J. (2019). *Percepción del usuario sobre el plan nacional para reducir la desnutrición crónica infantil y anemia implementado en Huancabamba, 2021* [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV.

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/91287>

- Fuentes Sandoval, L., Guerra Urbina, M., & Pulido Flores, N. (2019). *Factores que intervienen en la adherencia a la administración de multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 24 meses que acuden al Puesto de Salud Micaela Bastidas, 2018* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Ucayali].
- Guevara Vargas, L. (2019). *Percepción de las madres sobre la anemia en niños menores de un año, Centro de Salud-Pariona de Chota, 2019* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Cajamarca]. Repositorio Institucional UNC.
<https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3968>
- Hughes-Belding, K., Peterson, C., Clucas Walter, M., Dooley, L., & Bao, J. (2019). Quality home visits: Activities to promote meaningful interactions. *Infant Mental Health Journal*, 40(6), 816–829. <https://doi.org/10.1002/imhj.21779>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024). *Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023 - Nacional y Departamental*. INEI
- Luján-Del Castillo, C., & Gómez-Guizado, G. (2023). *Vigilancia de la situación del sobrepeso, obesidad y sus determinantes en el marco del Observatorio de Nutrición y estudio del sobrepeso y obesidad – Informe Técnico 2023*. Instituto Nacional de Salud
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5800474/5146110-informe-tecnico-situacion-del-sobrepeso-y-obesidad-en-marco-observatorio-2023.pdf>
- Mejía-Merino, C. M., Arango, S. P., & Londoño, Y. A. (2021). Evaluación de la intervención “Malnutrición por exceso de peso en la primera infancia” con base en el modelo de teoría del cambio, Medellín, Colombia, 2017. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 39(1), e340565. <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e340565>
- Ministerio de Salud del Perú. (2024). Norma Técnica de Salud: Prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad

fértil, gestantes y puérperas (NTS N° 213-MINSA/DGIESP-2024).

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6166763/5440166-resolucion-ministerial-n-251-2024-minsa.pdf>

Neisser, U. (1967). *Cognitive Psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. (2022). SUN Movement Strategy 2021-2025.

<https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2022/04/SUN-Movement-Strategy-2021-2025.pdf>

La Revista utiliza códigos para identificar al Revisor y al equipo de
PARES REVISORES. Si tiene dudas o consultas, contacte a:
contacto@cienciayreflexion.org
Código de Editor: 103
Código de Revisores: 432

